

## ESTADO DEL ARTE

Automatización del proceso de cancelación y reagendamiento de citas médicas mediante WhatsApp en la Atención Primaria de Salud.

### 1. ¿Qué se sabe del tema?

El ausentismo a citas médicas (conocido en la literatura como *no-show*) es una de las principales problemáticas operativas en los sistemas de salud pública a nivel global. La evidencia demuestra que la inasistencia no solo genera pérdidas financieras y subutilización de las horas de los profesionales de la salud, sino que alarga las listas de espera e interrumpe el seguimiento continuo de pacientes con condiciones crónicas (Dantas et al., 2018; Proyecto de Innovación CESFAM, 2024).

### 2. ¿Qué soluciones existen actualmente?

Para combatir el ausentismo, la gestión sanitaria ha evolucionado desde la atención presencial y telefónica hacia la adopción de canales digitales como portales web, aplicaciones móviles y mensajería instantánea (Molina et al., 2020). Diversos estudios confirman que la integración de recordatorios e interacciones a través de plataformas de uso cotidiano (como WhatsApp) incrementa significativamente la respuesta del usuario y facilita la liberación anticipada de cupos en comparación con los métodos tradicionales (Molina et al., 2020; Rodríguez & Sánchez, 2021).

### 3. ¿Cuál es la brecha de conocimiento o del sistema?

A pesar de la implementación de canales digitales de mensajería en centros de salud de atención primaria, la literatura y la práctica operativa muestran que la existencia de un canal por sí sola no resuelve el problema si la gestión interna sigue siendo manual (Dantas et al., 2018). Canales de WhatsApp atendidos manualmente presentan cuellos de botella y baja capacidad de procesamiento, dejando un gran volumen de solicitudes sin procesar a tiempo para reasignar las horas a otros usuarios en lista de espera (Proyecto de Innovación CESFAM, 2024).

### 4. ¿Cuál es el problema específico en nuestro contexto?

En el caso particular del CESFAM, el diagnóstico operativo señala que el uso actual de WhatsApp y los mecanismos de reagendamiento disponibles solo logran gestionar entre un 30% y un 40% del total de cancelaciones (Proyecto de Innovación CESFAM, 2024). Existe un 60% a 70% de cancelaciones o inasistencias que no se logran procesar de manera oportuna debido a la falta de un flujo automatizado, lo que deriva en un volumen crítico de horas médicas perdidas e irrecuperables (Molina et al., 2020; Proyecto de Innovación CESFAM, 2024).

### 5. Conclusión y Propuesta de Valor

Dado que los métodos actuales absorben menos de la mitad de las cancelaciones, se justifica plenamente el desarrollo e implementación de una solución automatizada integrada a WhatsApp (Rodríguez & Sánchez, 2021). Esta herramienta permitirá procesar la cancelación

y el reagendamiento en tiempo real, liberando automáticamente la agenda médica y mejorando la oportunidad y equidad en el acceso a la atención de salud (Dantas et al., 2018; Proyecto de Innovación CESFAM, 2024).

#### **Referencias (Normativa APA 7.<sup>a</sup> edición)**

- Dantas, L. F., Fleck, J. L., Cyrino Oliveira, F. L., & Hamacher, S. (2018). No-shows in appointment scheduling: A systematic literature review. *Health Policy*, 122(4), 412–421. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.02.002>[cite: 150, 151, 156, 158]
- Molina, R., Gómez, C., & Torres, P. (2020). Impacto de las tecnologías de mensajería instantánea en la reducción del ausentismo en atención primaria de salud. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 44(2), 15–23.[cite: 150, 151, 155, 156]
- Proyecto de Innovación CESFAM. (2024). *Informe de diagnóstico operativo sobre la tasa de cancelación e inasistencia a citas médicas*. Centro de Salud Familiar.[cite: 150, 155, 156, 158]
- Rodríguez, A., & Sánchez, M. (2021). Automatización de procesos mediante Chatbots en servicios públicos de salud: Una revisión sistemática. *Journal of Medical Systems*, 45(8), 102–111.